RENOVA

MÉTODO RENOVA · MUJERES 35+

NUTRICIÓN EN LA MENOPAUSIA

ENTENDÉ TU CUERPO, CUIDALO.

Qué cambia en la **perimenopausia** y la **menopausia**,
y cómo acompañarlo con **alimentación** y **hábitos**.



BIENVENIDA

Una etapa, no un problema

Para mujeres en **perimenopausia, menopausia o posmenopausia**. La menopausia no es una enfermedad: es una etapa de la vida. Pero trae cambios reales en el cuerpo, y entenderlos te ayuda a tomar mejores decisiones.



TE GUÍA

María Eugenia Ballini

Lic. en Nutrición · M.N. 11773 · Equipo RENOVA

En esta guía te explico, con evidencia y sin mitos, cómo la alimentación puede acompañar tu músculo, tus huesos, tu corazón y tu energía en esta etapa.

Cómo leer esta guía

- **Cada capítulo es corto** y termina con acciones concretas.
- **Marcamos el nivel de evidencia:** sólida, limitada o no demostrada, para que sepas qué está probado.
- **No es un tratamiento:** es educación. Las indicaciones individuales las da tu equipo de salud.
- **Complementa a Alimentación Inteligente:** allá te organizás y tenés las recetas; acá entendés la etapa.

Hacé clic y volvé al índice

CONTENIDO

Índice

Hacé clic donde quieras ir. Para volver al índice, abajo de cada página tenés el botón.

01 · Comprender la etapa 4

02 · Hormonas y composición corporal 7

03 · Proteínas y masa muscular 9

Nutrientes clave 11

04 · Salud ósea 12

05 · Alimentación y síntomas 14

06 · Salud cardiometabólica 16

07 · Suplementos y desinformación 19

08 · Alimentación en la vida real 21

09 · Mitos frecuentes 24

10 · Tu plan de continuidad 25

Herramienta: registro de síntomas 27

Fuentes y aclaraciones 28

Tu plan integral 1 a 1 29

01
Comprender la etapa

Perimenopausia, menopausia y posmenopausia no son lo mismo. Saber en cuál estás ayuda a entender lo que sentís.

ETAPA	QUÉ PASA	CUÁNDO
Perimenopausia	Los ovarios producen hormonas de forma irregular. Los ciclos cambian y pueden aparecer sofocos, alteraciones del sueño o del ánimo.	Suele empezar entre los 40 y los 50, y dura varios años.
Menopausia	Es el momento de la última menstruación. Se confirma después de 12 meses seguidos sin menstruar.	En promedio, alrededor de los 50.
Posmenopausia	Los estrógenos quedan bajos de forma estable. Cobra importancia cuidar huesos, músculo y corazón.	El resto de la vida, a partir de la menopausia.

Perimenopausia	**Menopausia**	**Posmenopausia**
Ciclos irregulares, primeros síntomas	Última menstruación (12 meses sin ciclo)	Estrógenos bajos estables

Hacé clic y volvé al índice

¿Por qué importa tanto el estrógeno?

El estrógeno no solo regula el ciclo: también participa en el mantenimiento del hueso, en la distribución de la grasa corporal, en el metabolismo de las grasas en sangre y en la regulación de la temperatura. Cuando baja, todo eso se modifica.

Cada mujer lo vive distinto. Hay quienes casi no tienen síntomas y quienes los sienten mucho. Si los síntomas afectan tu calidad de vida, consultá con tu ginecólogo/a: existen tratamientos efectivos y seguros para muchas mujeres.

En la práctica

- Anotá durante un mes tus ciclos y síntomas (sofocos, sueño, ánimo): te sirve para la consulta.
- Pedí un control ginecológico si tus ciclos cambiaron o tenés síntomas que te molestan.
- Empezá ya con fuerza y buena alimentación: cuanto antes, mejor llegás a la posmenopausia.

Hacé clic y volvé al índice

COMPRENDER LA ETAPA

Perimenopausia: los cambios empiezan antes

Muchas mujeres notan cambios **años antes** de la última menstruación, y no siempre los relacionan con esta etapa. Las hormonas suben y bajan de forma irregular, por eso los síntomas pueden ir y venir.

LO QUE PODÉS NOTAR	QUÉ HACER
Ciclos más cortos, más largos o más abundantes	Registrarlos y consultar si el sangrado es muy abundante o fuera de lo habitual.
Sofocos o sudoración nocturna	Identificar disparadores y consultar si afectan tu descanso.
Dormir peor, despertarte de noche	Rutina de sueño, menos cafeína y alcohol a la tarde y noche.
Cambios de ánimo, irritabilidad, más ansiedad	Movimiento, descanso y pedir ayuda si interfiere en tu vida.
Cambios en el peso y la cintura	Fuerza, proteína en cada comida y no hacer dietas extremas.

Es el mejor momento para empezar. Lo que construís en la perimenopausia —músculo, hueso, hábitos— es lo que te cuida en la posmenopausia.

02
Hormonas y composición corporal

No es solo “el metabolismo que se pone lento”: cambia dónde se acumula la grasa y cuánto músculo conservás.

Qué cambia

- **La grasa tiende a ubicarse más en el abdomen** (grasa visceral). La baja de estrógenos se asocia a este cambio, junto con la edad, el sueño y la actividad física.
- **Se pierde masa muscular** más rápido si no hay estímulo de fuerza.
- **Baja un poco el gasto de energía**, sobre todo por tener menos músculo y menos movimiento.
- **El sueño y el estrés** influyen en el apetito y en las elecciones de comida.



Hacé clic y volvé al índice

Qué podés hacer

01
Entrená fuerza
Es la herramienta principal para conservar y ganar músculo.

02
Proteína en cada comida
Ayuda a que el entrenamiento rinda (capítulo 3).

03
Calidad, no restricción
Dietas muy bajas en calorías aceleran la pérdida de músculo.

Evidencia sólida: el entrenamiento de fuerza con una alimentación adecuada en proteínas preserva la masa muscular en mujeres de mediana edad y mayores.

Mirá la cintura, no solo la balanza. El perímetro de cintura refleja mejor la grasa abdominal que el peso. Medilo cada 4 semanas, siempre igual.

En la práctica
- Medí tu cintura hoy y anotala.
- Agendá 2 o 3 sesiones de fuerza esta semana.
- Revisá si tus comidas tienen proteína y verduras.
- No hagas dietas muy restrictivas: cuidá el músculo.

Hacé clic y volvé al índice

03

Proteínas y masa muscular

Con los años, el músculo responde menos a la proteína. Por eso importa la cantidad, la calidad y cómo la repartís.

Tres claves

- **Repartila en el día:** una fuente de proteína en desayuno, almuerzo, merienda y cena rinde más que concentrarla en la cena.
- **Elegí fuentes variadas:** huevo, lácteos, carnes, pollo, pescado, legumbres, soja y derivados.
- **Combinala con fuerza:** la proteína sola no construye músculo; el estímulo del entrenamiento es el que lo hace.

MOMENTO	IDEAS DE PROTEÍNA
Desayuno	Yogur natural o griego, huevo, queso, leche
Almuerzo / cena	Pollo, carne magra, pescado, legumbres, tofu, huevo
Merienda	Yogur, queso fresco, hummus, frutos secos con lácteo

Las recomendaciones generales para adultos mayores sugieren que la necesidad de proteína puede ser algo mayor que en la juventud, sobre todo si entrenás. **La cantidad exacta para vos depende de tu peso, tu actividad y tu salud renal**: pedila a tu nutricionista.

Hacé clic y volvé al índice

Evidencia sólida: repartir la proteína en las comidas y combinarla con entrenamiento de fuerza favorece el mantenimiento muscular.

En la práctica

- Sumá proteína al desayuno: yogur, huevo o queso.
- Tené siempre a mano una proteína rápida: huevos, atún, legumbres de lata, yogur.
- Si no comés carne, combiná legumbres, huevo, lácteos y soja durante el día.

NUTRIENTES CLAVE

Nutrientes clave en esta etapa

NUTRIENTE	PARA QUÉ	FUENTES
Proteína	Músculo y hueso	Huevo, lácteos, carnes, pescado, legumbres, soja
Calcio	Hueso	Leche, yogur, quesos, sardinas, almendras, vegetales de hoja, alimentos fortificados
Vitamina D	Absorción de calcio, músculo	Sol, pescados grasos, huevo, alimentos fortificados
Fibra	Saciedad, intestino, colesterol	Verduras, frutas, legumbres, avena, integrales
Omega-3	Corazón	Pescados grasos (caballa, sardina, salmón), nueces, chía, lino
Hierro	Energía (clave si tenés sangrados abundantes)	Carnes, legumbres + vitamina C, vegetales de hoja

Las cantidades individuales las define tu nutricionista según tu edad, actividad y análisis.

Hacé clic y volvé al índice

04
Salud ósea

Después de la menopausia la pérdida de hueso se acelera. La buena noticia: hay mucho que podés hacer.

Ca
Calcio
Lácteos, quesos, yogur, sardinas con espinas, almendras, vegetales de hoja verde, bebidas vegetales fortificadas.

D
Vitamina D
Se forma con el sol en la piel; está en pescados grasos, huevo y alimentos fortificados.

P
Proteína
El hueso también necesita proteína para mantenerse.

F
Fuerza e impacto
El hueso responde a la carga: entrenar fuerza lo estimula.



Fuentes de calcio: lácteos, sardinas, almendras, vegetales de hoja verde, legumbres, tofu y sésamo.

Hacé clic y volvé al índice

- **Priorizá el calcio de los alimentos**: 2 o 3 porciones de lácteos por día cubren buena parte.
- **Vitamina D:** si tenés poca exposición al sol, pedí que te la midan. El suplemento solo con indicación.
- **Menos alcohol y nada de tabaco:** ambos aumentan la pérdida ósea.
- **Densitometría:** consultá con tu médico/a cuándo hacerla según tus factores de riesgo.

Evidencia sólida: calcio y vitamina D adecuados, junto con ejercicio con carga, son pilares en la prevención de la osteoporosis.

En la práctica

- Sumá 2 o 3 porciones de lácteos al día (o alternativas fortificadas).
- Pasá tiempo al aire libre; la exposición solar necesaria varía según estación, lugar, horario y tipo de piel. Preguntá si conviene medir tu vitamina D.
- Consultá por la densitometría y por medir vitamina D.
- Entrená fuerza: el hueso responde a la carga.

Hacé clic y volvé al índice

05
Alimentación y síntomas

Sofocos, sueño, apetito y energía: qué puede ayudar desde la alimentación y qué no tiene respaldo.

SÍNTOMA	PUEDE AYUDAR	EVIDENCIA
Sofocos	Identificar disparadores (alcohol, picante, café muy caliente, ambientes calurosos). Las isoflavonas de soja muestran un efecto modesto en algunas mujeres.	Limitada
Sueño	Cenar liviano y temprano, limitar cafeína después del mediodía y alcohol a la noche, horarios regulares.	Sólida (higiene del sueño)
Apetito y ansiedad	Comidas con proteína y fibra, no saltear comidas, dormir mejor y manejar el estrés.	Sólida
Energía	Comer a intervalos regulares, hidratarte, hacer actividad física y descartar déficit de hierro o vitamina B12 con tu médico/a.	Sólida
Salud intestinal	Fibra variada (verduras, frutas, legumbres, integrales), yogur y agua.	Sólida

Hacé clic y volvé al índice

Si los síntomas son intensos, la alimentación ayuda pero no siempre alcanza. La terapia hormonal y otros tratamientos son opciones que se evalúan con tu ginecólogo/a, según tu historia.

En la práctica

- Anotá qué dispara tus sofocos durante dos semanas.
- Cortá la cafeína después del mediodía y probá cenar más temprano.
- Si te cuesta dormir, armá una rutina: misma hora, poca pantalla, cuarto fresco.

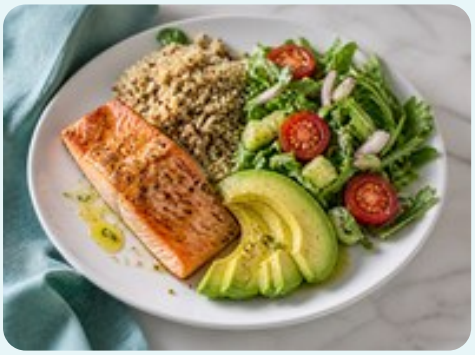
Hacé clic y volvé al índice

06
Salud cardiometabólica

Con la baja de estrógenos aumenta el riesgo cardiovascular. Es el momento de cuidar el corazón con hábitos.

Qué suele cambiar

- Sube el colesterol LDL (el “malo”).
- En algunas mujeres empeora la sensibilidad a la insulina; influyen la edad, la grasa abdominal y la actividad física, no solo las hormonas.
- Puede subir la presión arterial.



Un plato tipo mediterráneo: pescado, cereal integral, verduras, palta y aceite de oliva.

Hacé clic y volvé al índice

Qué ayuda

HÁBITO	CÓMO LLEVARLO A LA PRÁCTICA
Patrón tipo mediterráneo	Verduras, frutas, legumbres, integrales, aceite de oliva, frutos secos y pescado.
Fibra soluble	Avena, legumbres, frutas como manzana y cítricos: ayudan con el colesterol.
Menos sal	Cociná con hierbas y especias; leé el sodio en las etiquetas.
Grasas de calidad	Preferí aceite de oliva, palta, frutos secos y pescado; limitá frituras y procesados.
Menos azúcar agregada	Agua como bebida principal; postres ocasionales.
Movimiento	Fuerza 2 o 3 veces por semana y caminatas.

Evidencia sólida: el patrón alimentario mediterráneo y la actividad física regular reducen el riesgo cardiovascular.

Controles: pedí a tu médico/a perfil lipídico, glucemia y control de presión con la frecuencia que te indique.

Hacé clic y volvé al índice

En la práctica

- Cambiá la manteca por aceite de oliva y sumá frutos secos.
- Comé legumbres 2 o 3 veces por semana y pescado al menos 1 o 2.
- Cociná con hierbas y especias para usar menos sal.
- Pedí tus análisis de rutina.

Hacé clic y volvé al índice

07
Suplementos y desinformación

Hay muchos productos “para la menopausia”. Pocos tienen respaldo y algunos pueden tener riesgos.

SUPLEMENTO	QUÉ SE SABE
Vitamina D	Útil si hay déficit comprobado. La dosis la indica tu médico/a según tu análisis.
Calcio	Primero, de los alimentos. El suplemento se indica si la dieta no alcanza.
Proteína en polvo	Práctica si no llegás con comida; no es obligatoria.
Creatina	Evidencia creciente junto al entrenamiento de fuerza; consultá antes de usarla.
Isoflavonas de soja	Efecto modesto sobre sofocos en algunas mujeres; consultá si tenés antecedentes de cáncer de mama.
Productos “quemagrasa” o “detox”	Sin evidencia. Pueden interactuar con medicamentos.

- **Natural no significa seguro:** algunas hierbas interactúan con medicación o afectan el hígado.
- **Desconfiá de promesas rápidas** y de quien vende el producto que recomienda.
- **Antes de tomar cualquier suplemento,** contale a tu médico/a qué medicación tomás.

Hacé clic y volvé al índice

En la práctica

- Hacé una lista de lo que tomás hoy (medicación y suplementos) y llevala a la consulta.
- Antes de comprar un suplemento, preguntate: ¿tengo un déficit comprobado?
- Desconfiá de “resultados rápidos” y “naturales sin riesgos”.

Hacé clic y volvé al índice

08
Alimentación en la vida real

Llevar todo esto a una semana con trabajo, familia y poco tiempo.

Un día de ejemplo

MOMENTO	EJEMPLO
Desayuno	Yogur natural con avena, fruta y semillas
Almuerzo	Pollo con ensalada de hojas, garbanzos y aceite de oliva
Merienda	Tostada integral con queso y una fruta
Cena	Pescado al horno con verduras y papa

Es un ejemplo para orientarte, no un menú obligatorio. En **Alimentación Inteligente** tenés 8 semanas de recetas y combinaciones.

Tres situaciones frecuentes

- **“No tengo hambre a la mañana”:** empezá con algo chico con proteína (un yogur) y sumá más a media mañana.
- **“A la noche me agarra la ansiedad”:** revisá si comiste suficiente proteína y fibra durante el día; la cena temprana y completa ayuda.
- **“Viajo o tengo eventos”:** elegí proteína y vegetales cuando puedas, hidratate y volvé a tu rutina en la comida siguiente.

Hacé clic y volvé al índice

En la práctica

- Elegí un desayuno con proteína para esta semana.
- Prepará dos comidas de respaldo para los días complicados.
- Usá el programa de 8 semanas de Alimentación Inteligente para organizarte.

Hacé clic y volvé al índice

CASOS PRÁCTICOS

Tres situaciones de la vida real

Laura, 46 · perimenopausia

Duerme mal y a la noche pica. **Qué cambia:** cena completa con proteína, sin café después de las 14, rutina de sueño y registro de síntomas para su consulta.

Claudia, 53 · posmenopausia

Su densitometría salió baja. **Qué cambia:** 3 porciones de lácteos al día, fuerza 2 veces por semana, consulta por vitamina D y seguimiento médico.

Silvia, 49 · viaja por trabajo

Come en aeropuertos y hoteles. **Qué cambia:** yogur y frutos secos en la cartera, proteína y verduras en el menú, y fuerza en la habitación 20 minutos.

Mariana, 51 · sofocos

Los sofocos la despiertan. **Qué cambia:** identifica que el vino y el picante los empeoran, ajusta la cena y consulta con su ginecóloga por opciones de tratamiento.

Casos ilustrativos, no personas reales. Cada situación necesita una evaluación individual.

Hacé clic y volvé al índice

09
Mitos frecuentes

Lo que circula en redes y lo que dice la evidencia.

Mito: “En la menopausia hay que dejar los carbohidratos.”

Realidad: no hace falta eliminarlos. Elegí integrales, legumbres y frutas, y ajustá la cantidad a tu actividad.

Mito: “El ayuno intermitente es lo mejor para esta etapa.”

Realidad: puede servirle a algunas personas, pero no es superior a otras formas de comer y puede dificultar llegar a la proteína que necesitás.

Mito: “La soja es peligrosa.”

Realidad: como alimento (tofu, porotos de soja, bebida) forma parte de una alimentación saludable. Si tenés antecedentes oncológicos, consultá.

Mito: “Los lácteos inflaman.”

Realidad: no hay evidencia de eso en la población general, y son una fuente clave de calcio y proteína.

Mito: “Subir de peso es inevitable.”

Realidad: los cambios son reales, pero la fuerza, la proteína, el sueño y el movimiento diario marcan una gran diferencia.

Mito: “Hay que hacer mucho cardio para bajar la panza.”

Realidad: la fuerza es prioridad para conservar músculo; el cardio suma, pero no reemplaza.

Hacé clic y volvé al índice

10
Tu plan de continuidad

Elegí tus prioridades, llevá preguntas a la consulta y medí lo que importa.

Guía para tu consulta

Con tu ginecólogo/a o médico/a

- ¿En qué etapa estoy?
- ¿Conviene una densitometría? ¿Cada cuánto?
- ¿Medimos vitamina D, hierro o B12?
- ¿Cómo están colesterol, glucemia y presión?
- ¿La terapia hormonal es una opción para mí?

Con tu nutricionista

- ¿Cuánta proteína necesito con mi entrenamiento?
- ¿Llego al calcio con mi alimentación?
- ¿Necesito algún suplemento?
- ¿Cómo adapto mis comidas a mis síntomas?

Llevá: tu registro de síntomas (página 27), la lista de medicación y suplementos, y tus últimos análisis.

Mis 3 prioridades para este mes

PRIORIDAD	QUÉ VOY A HACER	CÓMO LO MIDO
1		
2		
3		

Cada 4 semanas medí: perímetro de cintura, tu fuerza (repeticiones o peso) y cómo dormís y tu energía (del 1 al 10).

Hacé clic y volvé al índice

HERRAMIENTA

Registro de síntomas y hábitos

Completalo 2 semanas antes de tu consulta. Puntuá del 0 (nada) al 3 (mucho). En “Actividad”, anotá si entrenaste o caminaste; en “Hábito”, el que estés trabajando. No sirve para diagnosticar: es información para tu profesional.

DÍA	SOFOCOS	SUEÑO	ÁNIMO	ENERGÍA	ACTIVIDAD	HÁBITO
Lun						
Mar						
Mié						
Jue						
Vie						
Sáb						
Dom						

Hacé clic y volvé al índice

FUENTES

Fuentes y aclaraciones

- Ministerio de Salud de la Nación (2016). *Guías Alimentarias para la Población Argentina*. argentina.gob.ar/salud
- Organización Mundial de la Salud (2024). *Menopausia* (nota descriptiva). who.int/news-room/fact-sheets/detail/menopause
- The North American Menopause Society (2022). The 2022 hormone therapy position statement. *Menopause*, 29(7), 767–794. doi:10.1097/GME.0000000000002028
- The Menopause Society (2023). The 2023 nonhormone therapy position statement. *Menopause*, 30(6), 573–590. doi:10.1097/GME.0000000000002200
- El Khoudary, S. R., et al. (2020). Menopause transition and cardiovascular disease risk. *Circulation*, 142(25), e506–e532. doi:10.1161/CIR.0000000000000912
- International Osteoporosis Foundation. *Nutrition and bone health*. osteoporosis.foundation

Material educativo general. Esta guía no reemplaza la consulta médica, ginecológica ni nutricional. No indica tratamientos, dosis de suplementos ni cantidades individuales de nutrientes. Ante síntomas, enfermedades o medicación, consultá con tu equipo de salud.

Revisión de contenidos: María Eugenia Ballini, Lic. en Nutrición · M.N. 11773.

Hacé clic y volvé al índice

PLAN INTEGRAL RENOVA

Tu plan integral 1 a 1 con Nacho



Consultá por tu plan integral personalizado 1 a 1 con Nacho: entrenamiento y nutrición armados para vos y tu etapa, con el equipo RENOVA.

CONSULTÁ POR TU PLAN →

Esta etapa no es un final. Es un buen momento para cuidarte.

Hacé clic y volvé al índice